

Fecha Última Actualización: 20-02-2023 13:04:18

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Juana Rosa Painenao Coilla
Edad : 69a 4m 23d
Dirección : Volcan Viedma 3843

Rut : 7.476.380-4
Fecha Nacto: 28/09/1953
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 9522474
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 2094 2036

N° Epicrisis
341518

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 25/01/2023 20:07

Días Estadía: 26

Unidad de Egreso : Medicina Agudos (4tp Piso)

Fecha Egreso : 20/02/2023 13:02

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Shock séptico foco pulmonar / NAC ATS IV

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Nombre: Juana Rosa Painenao Coilla
RUT: 7476380-4
Edad: 70 años
FI CASR: 21/01/2023
FI HOSMET: 23/01/2023
FRI CASR/UCI: 25/01/2023
FI UTIM: 08/02/2023
FI Sala: 16/02/2023
Contacto: 9 2094 2036

Antecedentes:

- Mórbidos: HTA, DM2 NIR, Fibrosis Pulmonar en estudio, Artrosis
- Quirúrgicos: Colecistectomía, Apendicectomía, Hernia Lumbar, Cirugía endoscópica nasosinusal
- Fármacos: Iltuxam (Olmesartán/Amlodipino), Metformina, Atorvastatina, Bromuro de Ipratropio, Paracetamol
- Alergias: PNC Benzatina, Amoxicilina
- Hábitos: TBQ (+) suspendido hace 1 año (aprox. 3 cig/d), OH (+), Drogas (-)
- Inmunizaciones: COVID-19 (+) 3 dosis

Historia de ingreso:

Paciente con los antecedentes descritos, consulta por cuadro de 1 semana de evolución de tos, disfonía y CEG, al que se le suma fiebre hasta 39°C y tope inspiratorio. Consulta inicialmente en hospital de base, donde se realiza AngioTAC, con neumonía bibasal de predominio izquierdo y atelectasia ipsilateral, sin TEP ni COVID.

Evoluciona con requerimientos de O2 al alza, mala mecánica ventilatoria, hipoxemia y acidosis, por lo que se realiza traslado a UCI dado necesidad de VMI.

Ingresa con leve taquicardia, Sat >92% en VMNI, al US con derrame pleural izquierdo de carácter heterogéneo, loculado, y con signos de organización, concordante con empiema pleural subyacente paraneumónico, por lo que se inicia Ceftriaxona + Amikacina

TAC de Tórax con extenso derrame pleural, de mayor compromiso a lado izquierdo, con NP de 9.5 mm en LII. Dado evolución desfavorable, se decide IOT con VMI, y traslado a HSR para evaluación por CxTx por derrame pleural con sospecha de empiema

Fecha Epicrisis : 20/02/2023 13:04

Página 1 de 3

Evolución por planes:

1. Hemodinamia: A su ingreso a UPC DVA NAD hasta 0.22 mcg/kg/min en contexto de sepsis, tras manejo de intercurrentias logra suspender 03/02. Evoluciona con PA en rango, destaca taquicardia sinusal que impresiona en contexto de dolor, fiebre e hipovolemia, con buena respuesta a volemicización y optimización de analgesia. Sin conflicto posterior, hemodinamia autosostenida.

2. Ventilatorio/Infeccioso: ingresa por NAC ATS IV y derrame paraneumónico con necesidad de VMI con IOT el 24/01. En manejo ATB con Ceftriaxona + Amikacina, a su ingreso se realiza toracocentesis, con pH 7.5, predominio hemático. Con imagen concordante con foco de condensación de LII además de DP bilateral mayor a izquierda. Se solicita evaluación por Cirugía de tórax, que instalan drenaje pleural el 27/01, y se aísla de muestra SAMR, además de CAET (+) para el mismo agente, por lo que se ajusta tratamiento a Linezolid (FI 28/01), y posteriormente a Vancomicina (30/01). Evoluciona de manera favorable, logrando extubación el 04/02, disminuyendo progresivamente requerimientos de O2 hasta suspensión. Se mantiene con tratamiento con Vancomicina por 14 días con buena respuesta clínica y con reducción progresiva de débito de drenajes pleurales, siendo retirados el día 14/02. El 09/02 presenta peak febril, se pancultiva y se escala a Imipenem. Cuenta con SO inflamatorio, UC (-), CVC (-), HCs (-). Se interpreta como ITU con organismo no identificado, se completan 7 días de Imipenem con buena respuesta. Se inicia Cotrimoxazol forte (16/02) para completar 4 semanas de tratamiento ATB para empiema.

3. Nefrológico/Medio Interno: A su ingreso con creatinina en 1.27 (basal desconocido), que corrige tras manejo inicial. Además de tendencia a hipernatremia, hipokalemia e hipofosfemia, en corrección durante estadía, sin alteración de la función renal. Evoluciona con acidosis metabólica con AG aumentado persistente, resistente a la administración de bicarbonato, y poliuria marcada con hiponatremia e hipokalemia, por lo que se sospecha nefropatía perdedora de bicarbonato, se inicia estudio urinario y espironolactona. Sin embargo, evoluciona con mejoría de parámetros, poliuria se interpreta en contexto de depleción de volumen. Posteriormente sólo presenta hipokalemia moderada que responde favorablemente a carga EV de potasio

4. Metabólico: DM2 NIR, con buen control durante estadía, en manejo con insulina cristalina titulando según necesidad. Se rescata HbA1c en 10.1%.

5. Rehabilitación/Nutricional: Alimentándose inicialmente con régimen mixto oral y SNG (inicia NE el 30/01). Evaluado por FNA se logra suspensión precoz de NE, con progresión a régimen enteral por boca con buena respuesta y sin restricción de consistencias. Se realiza rehabilitación motora por kinesiológica.

6. Hematológico: se pesquisa anemia moderada normocítica hasta Hb 7.7, sin alteración de otras series. Hemodinamia estable, sin gatillo transfusional. Se deriva para evaluación de forma ambulatoria.

Diagnósticos de alta:

1. Shock séptico de foco pulmonar resuelto
 - Neumonía ATS IV
 - Empiema paraneumónico por SAMR
 - Tubo de drenaje pleural 28/01 - 14/02
2. Insuficiencia respiratoria aguda resuelta
 - VMI 24/01 - 04/02
3. Miopatía de paciente crítico en rehabilitación
4. Anemia moderada normo-normo
5. ITU tratada
6. Falla renal KDIGO I resuelta
7. LPP sacra grado 2
8. Antecedentes: Fibrosis Pulmonar?, DM2 NIR, HTA, TBQ Crónico

Diagnóstico de Egreso

Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) - Complicada con empiema por SAMR tratada
Insuficiencia Respiratoria aguda parcial - resuelta

Condición de Egreso Alta Hosp. Domiciliaria

Egreso con Catéter Doble J:NO

Buenas condiciones generales, hemodinamia estable, afebril, sin requerimientos de O2 suplementario. Buena tolerancia oral.

Fecha Epicrisis : 20/02/2023 13:04

Página 2 de 3

Plan Post Alta

Reposo relativo, progresar en rehabilitación motora con kinesiología en Hospitalización domiciliaria
Régimen diabético e hiposódico

Medicamentos:

- Cotrimoxazol forte (160/800 mg), 1 comprimido cada 12 horas vía oral hasta el 26 de febrero de 2023 (inclusive)
- Paracetamol 500 mg, 2 comprimidos vía oral SOS caso de dolor y/o fiebre > 37.8° C, máximo cada 8 horas
- Pregabalina 75 mg, 1 comprimido en la noche vía oral
- Mantener fármacos de uso crónico

Controles:

- Control con Cirugía de tórax, solicitar hora en pasillo 11 CDT Hospital Sótero del Río con esta epicrisis.
- Realizar radiografía de tórax, el mismo día que sea el control con cirugía de tórax (se entrega orden).
- Control con medicina interna para evaluación de anemia, solicitar hora en CDT Hospital Sótero del Río con esta epicrisis.
- Control en consultorio o con su médico tratante para optimizar tratamiento de diabetes.

Consultar al servicio de urgencias en caso de: dificultad para respirar, fiebre > 37.8° C, dolor intratable que no ceda con medicamentos, en caso que lo estime necesario.

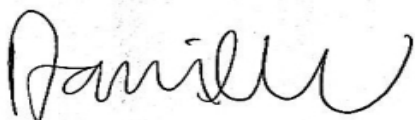
Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Con 200 G De Hidratos De Carbono

Medicamentos : Paracetamol 500mg 2 Comprimidos Cada 8 Horas Vía Oral Por 5 Días, Luego Sos En Caso De Fiebre O Dolor
Cotrimoxazol Forte 1 Comprimido Cada 12 Hrs Vía Oral Hasta El 26/02/23 Inclusive

Controles



Daniela Weber Faúndez

STAFF

Becado/Residente



Bec. Diego Antonio Bec Olivares F

Médico Tratante (Staff)